DOI:10.16482/j.sdwy37-1026.2025-01-004

失语症患者语言功能康复治疗的三个理论视角

崔刚[1] 王小丽[2]

(1. 清华大学 外文系,北京 100084;2. 中国人民大学 外国语学院,北京 100872)

[摘要] 失语症是由于脑损伤所导致的语言障碍,它会严重影响患者的语言交际能力,并由此而引起生活质量下降以及一系列的心理与精神问题。医疗手段可以改善脑损伤的状况,并且可以带来语言功能的一定程度的恢复。但是,在进行医学治疗的同时,还需要通过一定的康复方案加快患者语言功能改善的进程。因此,失语症患者语言功能的康复一直是相关领域关注的重要问题。人们从神经生物学、认知神经心理学和语言学三个不同的理论视角出发,提出了多种不同的康复方案。本文以上述三个理论视角为主线,对各种康复方案进行全面的梳理、总结与评述,并对今后的发展方向进行讨论。

[关键词] 失语症患者;语言功能;康复治疗;理论视角

[中图分类号] H030 [文献标识码] A [文献编号] 1002-2643(2025)01-0031-11

Three Theoretical Perspectives for Language Rehabilitation Therapy of Aphasics

CUI Gang[1] WANG Xiaoli[2]

(1. Department of Foreign Languages and Literatures, Tsinghua University, Beijing 100084, China;
2. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: Aphasia is a language disorder caused by brain damage. It seriously affects patients' language communication ability, leading to their sharp decline in life quality, or even incurring some mental problems. While medical measures can improve the condition of brain injury and bring about a certain degree of recovery in language ability, special language treatment is highly needed to further rehabilitate patients' language. So far, various therapies have been proposed and practiced. This paper combs through those therapies from three theoretical perspectives, namely, neurobiology,

收稿日期:2024-09-15;**修改稿**:2024-11-18;**本刊修订**:2025-01-09

基金项目:本文为国家社科基金后期资助项目"失语症语法障碍及其康复研究"(项目编号:23Z300600841)的阶段性成果。

作者简介:崔刚,博士,教授,博士生导师。研究方向:心理语言学,神经语言学与外语教学。电子邮箱:cuigang@mail.tsinghua.edu.cn。

王小丽,博士,讲师。研究方向:神经语言学,生成语法,失语症。电子邮箱:wxl@ruc.edu.cn。

引用信息:崔刚,王小丽.失语症患者语言功能康复治疗的三个理论视角[J].山东外语教学,2025,(1):31-41.

中国知网 https://www.cnki.net

cognitive neuropsychology and linguistics. Based on the introduction and review of them, discussion about the future directions is also made.

Key words: aphasia; language function; rehabilitation therapy; theoretical perspectives

1. 引言

失语症是由于脑损伤所导致的语言障碍,患者会在言语表达、听力理解、阅读和写作等方面呈现出明显的能力低下,这不仅影响他们日常生活中的语言交际能力,还会影响患者的社会交往、娱乐休闲和工作,并有可能带来一系列的心理与精神问题。因此,失语症患者语言功能的康复一直是相关领域研究的一个重要议题。一个多世纪以来,伴随失语症的科学研究,学者们从多学科、多角度出发对失语症的康复治疗进行了研究,并提出了诸多的康复方案。本文拟从神经生物学、认知神经心理学和语言学三个理论视角对失语症康复研究进行梳理,对其理论与实践做简要的介绍,并以此为基础对今后的相关研究展开讨论。

2. 神经生物学的理论视角

神经生物学从分子、细胞、环路、系统等层次探究脑与神经系统的运行原理与机制,其中神经可塑性理论为失语症患者语言功能的康复提供了基本的理论基础。神经可塑性是指人脑根据内部或外部环境的变化而不断进行结构和功能的自我调整与修正的能力(Fridriksson & Smith, 2016)。在脑损伤的情况下,这种能力表现为神经元的形态学变化,例如轴突发芽(axonal sprouting),受损伤的轴突残端可能长出新的终端与神经系统中的其他神经元联结,未受损伤神经元的树突或轴突也可能向受损伤的神经元长出新芽,这种新的突触联结可以加强已有的神经联结,或者形成新的神经联结,从而代偿损坏的神经通路,有助于实现神经系统功能的恢复。神经可塑性表现在大脑皮质的功能重组上,例如,大脑某个半球皮质的某些区域受到损伤,位于同侧的临近皮层区域或者对侧半球的相对应区域有可能会补偿该区域的部分功能。另外,某些在正常状况下不常使用的潜伏神经通路也可能会得到启用。神经可塑性为康复方案的制订奠定了基本的理论基础。Luria (1970)较早提出了功能重组路径(functional reorganization approach),认为应该在治疗中倡导患者积极地通过新方式来实现原本受损的语言功能,他将利用一个“完整”的系统来促进另一个受损系统的性能称为“系统间重组”(intersystemic reorganization)。功能重组的思想以及其他方面的神经可塑性催生了许多具体的言语康复方案,这些方案可以分为行为疗法和刺激疗法两种类型。

2.1 行为疗法

行为疗法是通过言语或非言语的外部行为训练而进行的语言康复,其中最为经典的是 Schuell et al. (1955)所提出的刺激疗法(Stimulation Approach)。把该康复方案归入行为疗法的范畴是因为它是通过语言材料间接刺激相关脑组织的方式,其名称也反映了在

中国知网 https://www.cnki.net

神经生物学视角之下行为疗法与刺激疗法的共同之处。它们都力图刺激或激活相应的脑组织,通过神经可塑性带来脑内部结构与功能的变化,从根本上改善语言使用的神经机制,从而收到提高患者语言能力的效果。刺激疗法采用丰富多变且有意义的语言材料作为刺激物,给予与语言损伤相关的多途径语言刺激。这种方案的提出距今已有近七十年,但依然是失语症治疗中最常用的方法之一。音乐疗法也是近年来颇受关注的康复方案,与 Schuell 刺激疗法所不同的是,该方案不直接针对大脑的语言功能区,而是通过音乐激活大脑右半球的相关组织,使其可以代偿语言功能的缺失(Chea et al. , 2024)。音乐疗法最典型的代表是由 Albert et al. (1973)提出的旋律语调疗法(Melodic Intonation Therapy, MIT),倡导将音乐元素,如旋律和节奏等纳入治疗以促进语言康复。治疗师首先将一些语言项目嵌入到韵律相同的歌曲中,或将语言项目的韵律转换为旋律语调模式,和患者一起唱出词汇和短语,然后逐渐减少旋律的参与,让患者尝试以正常的语调复述句子。与此同时,治疗师还可要求患者同时使用左手对应每个音节打拍子。音乐疗法还包括定向音乐疗法(Directed Music-Supported Training)、语言性音乐治疗(Speech-Music Therapy for Aphasia)以及歌唱疗法(Singing therapy)等(张梦瑶,2023)。

2.2 刺激疗法

刺激疗法通过采用非侵入式脑刺激技术激活相关脑区的方式进行失语症的康复治疗。主要有两种激活模式,一种是继续依赖保留的语言区域,通过刺激损伤部位的邻近皮层以实现功能的再激活;另一种是激活非传统的语言区域,通过刺激完好的、与损伤部位位于同侧的脑组织或者对侧半球与脑损伤部位相对应的区域以实现功能的重组。目前所采用的技术主要包括经颅磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)和经颅直流电刺激(transcranial Direct Current Stimulation, tDCS)。TMS 通过磁脉冲刺激来激发或者抑制局部大脑皮层的功能,目前多采用重复性(repetitive)经颅磁刺激技术(rTMS),其中脉冲的频率决定了所产生的效果,低频刺激(1 赫兹左右)会起到抑制的作用,而高频刺激(大于 5 赫兹)会起到激活与兴奋的效果。tDCS 通过用凝胶海绵电极施加弱而持续的电流达到刺激大脑皮层的效果。tDCS 分为阳极与阴极电极刺激,前者会使大脑皮质的兴奋性提高,后者则相反。Naeser 及其同事(Martin et al. , 2004; Naeser et al. , 2005)最早把 rTMS 技术应用于失语症康复治疗之中,他们认为患者左半球的脑损伤会使得右半球过度激活,从而使得左右半球的功能失衡,因此,要通过抑制右半球中与左半球语言区相对应的脑区,以便恢复左右半球的平衡,引起左半球语言区结构的优化,进而带来语言功能的改善。这一思路对后来的刺激疗法产生了重要的影响,但是也有一些研究采用了不同的方案。例如,Jung et al. (2011)在使用 tDCS 技术时采用了阴极电极刺激左半球额叶以抑制其兴奋程度的做法;Vines et al. (2011)使用阳极电极刺激右半球额下回以提高其兴奋性;Szaflarski et al. (2018)则采用了 rTMS 技术通过高频脉冲刺激左半球额下回的方式。除了采用非侵入式脑刺激技术之外,我国的中医针刺疗法也可以归入刺激疗法的范畴。它使用金属制针具刺激人体特定穴位,最大程度地保持健康的脑细胞,并使受到损伤的脑

中国知网 https://www.cnki.net

细胞恢复正常的形态结构,继而有利于语言功能的恢复。

3. 认知神经心理学的理论视角

认知神经心理学以信息加工理论为指导,研究人类认知的过程及其神经基础, 其中语言的学习与加工是其核心内容之一。认知神经心理学主张功能与解剖的模块性,认为人类的认知系统由一系列相对独立而又相互协同的成分组成,各个组成部分具有模块的特点,可以独立运作并承担各自的功能,这些模块可以定位于大脑的不同部位,因此,脑损伤会导致信息加工过程某些环节的选择性障碍。另外,它还主张认知系统及其神经基础的缩减性(subtractivity),认为脑损伤可以破坏或损伤认知系统的一个或者多个模块以及模块之间的联结,但是不会产生新的信息加工系统。脑损伤患者可以借助患病之前具备的认知系统、采用与正常人不同的机制来完成某些认知任务,从而形成一定的认知代偿机制。例如,一个患有严重面部识别障碍(prosopagnosia)的患者可能会通过人的衣着或声音去识别他们,这种新启用的认知途径在正常人的认知结构中已经存在,只是正常人可能不使用或较少使用它,而患者在病理条件下却充分调用了该途径(Whitworth et al. , 2014)。认知神经心理学的创立和发展使得失语症研究可以在正常人认知模型的参照下进行, 研究者以明晰的语言加工理论为基础,对患者的语言障碍做出推论,将观察到的症状与底层功能结构中一个或多个组件的损坏关联起来,并基于信息加工模型对语言障碍进行分类和描述,从而制订出具有明确指向性的语言康复方案,这些方案可以被分为认知功能训练和语言加工能力训练两种类型。

3.1 认知功能训练

大多数的失语症患者均存在认知功能障碍,这些障碍使得语言加工不能顺利进行。认知功能训练主要围绕信息加工系统中的知觉、注意、记忆等环节以及思维能力展开,力图通过认知功能的改善提高语言能力。知觉训练包括图片拼图、空间定位、物体辨认、残字识别、单侧注视等。注意力训练包括注意的保持、广度、选择、转移与分配等方面。例如,可以给出目标字母让患者从字母行中找出相应的字符,也可以让患者找出两张相似图片之间的异同。起初训练一般在比较安静的室内,然后逐渐向嘈杂的环境转移以达到训练其注意力的目的。记忆训练包括言语、人物、空间记忆等方面,例如,可通过引导患者观看视频或图片激发其记忆等。思维训练包括概念形成、逻辑推理、系列思维等。例如,引导患者看报纸或书籍找出信息点展开联想或进行推理,也可以给其一些简单的数字排列,让其推理回答问题等(杨悦,2019;朱仁敬等,2020)。

3.2 语言加工能力训练

从认知神经心理学的视角来看,失语症的语言康复不能只关注表面症状,还要对照正常人的语言加工模型,识别并聚焦患者特定的语言加工障碍。语言加工训练以心理语言学关于语言加工的理论为基础,通过对失语症患者语言症状的分析,确定语言障碍产生的

中国知网 https://www.cnki.net

认知原因,然后根据语言加工的特点以及具体环节制订康复方案。目前的康复方案大多针对失语症患者的词汇障碍,尤其是名词与动词的产出能力。例如,Rose & Douglas (2008)针对名词命名过程中语义提取的问题采用了言语治疗(在患者不能命名时要求说出该名词的语义特征)和手势治疗(在患者不能命名时要求用手势进行描述)的方法。Webster & Gordon (2009)针对动词产出过程中的语义提取问题采用了动词与名词关联的方法,要求患者朗读动词,找出相关的名词并产出句子。相关的训练方法非常之多,Whitworth et al. (2014)列出了29个名词康复训练和13个动词康复训练的典型案例。近年来较受关注的是语义成分分析法(Semantic Feature Analysis, SFA),该方法主要基于语义的扩散激活模型理论,依赖于重新学习或应用已学知识促进相关语义特征之间的激活,进而推动目标词汇的提取。SFA治疗方案需要使用一个"特征分析表",名词的特征通常包括物体的组别、涉及的动作、功能、位置等(Boyle, 2010),动词的特征则通常包括动作主体、目的、位置等(Wambaugh et al., 2014)。治疗师会为患者展示图片,鼓励患者通过回答一系列问题而完成特征分析表,从而逐渐完善目标词汇的语义特征。近年来,SFA也得到了不断改进,如改善语义特征的典型性(Kiran, 2007)或者改变语义特征数量(Hashimoto & Frome, 2011)等,有的康复方案也要求患者产出句子,以提高SFA的适用性(Gilmore et al., 2020)。此外,SFA还衍生出了音素成分分析法,使用相同音素开头的词以加强对目标词的激活(Kristensson & Saldert, 2018)。

认知神经心理学视角下句子层面的康复方案要相对少一些,但是学者们也提出了一些与此相关的治疗方法。例如,映射疗法(Mapping Therapy)主要针对语法缺失患者在句子理解方面的特殊困难,它认为患者的句法结构没有受到损伤,只是无法把施事、受事等题元角色与主语、宾语等论元结构正确对应起来(Saffran et al., 1998)。该方案包括三个模块,分别对应句子理解的不同环节,第一个模块针对形态句法的困难,第二个模块针对动词的提取和映射规则问题,第三个模块针对题元角色的分配障碍(Schwartz et al., 1995)。结构启动法(Structural Priming)是一种针对句子产出困难的康复方案,它基于词汇启动现象,即当人们感知或产出一个词时,该词的表征会在短时间内变得更容易提取,从而增加该词在短期内被再次激活的效率。该现象不仅被应用于词汇训练,也被证实在失语症患者对复杂句型的产出中具有积极作用(Man et al., 2019)。Lee & Man(2017)使用了结构启动疗法提高患者所产出句子的句法复杂程度。他们首先要求患者模仿治疗师复述含有特定句法结构的句子,继而患者需要使用这个句法结构自主完成图片描述任务。

4. 语言学的理论视角

神经语言学的发展使得人们越来越认识到语言学理论在失语症治疗中不可或缺的作用(常辉、王海燕,2024)。语言学理论不仅被用于描述与分析失语症的语言损伤,也成为许多康复方案设计的理论基础。神经生物学和认知神经心理学视角下的语言康复方案大

中国知网　https://www.cnki.net

多从语音和词汇两个层级进行,而语言学理论则极大地促进了句子层级康复方案的制订,为增强失语症患者句子产出与理解能力提供了很大的帮助。

4.1 结构主义语言学

结构主义语言学认为语言是具有不同层次和组成部分的结构,它采用切分法和分类法对语音、形态以及句法的成分进行了客观的描述与分析,为失语症患者语言障碍,尤其是句法障碍的描述与分析以及康复方案的制订提供了良好的理论基础。例如,Gleason et al.(1975)用完成故事的方法让 8 例语法缺失患者产出 14 种句法结构,并根据其表现在 14 种句法结构之间建立起了难度层级。以此为基础,Helm-Estabrooks et al.(1981)设计了专门针对句法障碍的 HELPSS(Helm Elicited Language Program for Syntax Stimulation)康复方案,该方案选取包括祈使句、Wh-问句、陈述句、被动句和嵌套句等在内的 11 种句法结构,每种包含 20 个具体例句,每个例句配有简单图画。先由治疗师示范产出特定的句法结构,然后由患者模仿尝试产出,接着由患者自主完成图片故事叙述,当患者对该结构产出的正确率达 90%以上时,进入下一个句法结构。

4.2 生成语法理论与其它

从上个世纪 60 年代开始,生成语法理论逐渐成为当代语言学的主流。它以句法为核心,将语言视为人类的基本认知官能。许多学者以生成语法理论为基础解释失语症患者句子理解和产出中的问题,例如,Friedmann & Grodzinsky (1997)提出了句法树剪裁假说(Tree Pruning Hypothesis),并以此为基础进行了语言康复的研究(Friedmann et al., 2000)。在这些利用生成语法理论进行失语症康复的研究中,复杂性治疗理论(Complexity Account of Treatment Efficacy, CATE)(Thompson & Shapiro, 2005; 2007)最受关注,它也被称为“针对底层形式的治疗(Treatment of Underlying Forms)”。该理论主张从句子的深层结构入手定位语言障碍。对于受损的句子结构,应该首先关注句子内部词汇层的论元结构(argument structure),然后是句子的移位等句法操作。另外,它更加关注复杂性,认为如果患者能够在语言训练中掌握复杂的句法结构,那么他们自然也会掌握简单的句法结构。如研究发现,失语症患者在处理动词时存在不同程度的损伤,其中三价动词受损最严重,而一价动词受损最轻(Thompson, 2003)。因此,康复训练应该从三价动词开始,因为这是最复杂的情况,一旦患者能够处理三价动词,他们自然就能够处理二价和一价动词。

其他语言学理论也被应用于失语症康复之中。例如,以格语法(Fillmore, 1968)为基础,Loverso et al. (1986)提出了动词启动治疗方案(Cueing Verb Treatment, CVT)以帮助失语症患者产出简单的句子。格语法是 Fillmore (1968)在早期生成语法的影响下提出的理论,重点研究深层结构中的语义格,认为在深层结构中,动词总是与某些语义格连用才能生成正确的句子,而这些语义格都是由做论元的名词短语来实现的。因此,该治疗方案首先训练动词,然后在一系列渐进的步骤中逐步扩展,并根据动词类型使其既包括主语,又包括宾语或位置、时间状语、工具等。句子扩展由治疗师控制使用的疑问词产生,例如,“谁跑了”会启发患者产出“我跑了”,“谁什么时候跑了”会启发患者产出“我昨天跑了”等。

中国知网 https://www.cnki.net

5. 讨论

来自各个领域的研究者已经对失语症患者语言功能的恢复进行了大量的研究,提出了众多的康复方案,也都取得了不同程度的治疗效果。然而接近百分之六十患者的语言功能在一年之后仍然不能得到很好的恢复(Pedersen et al. , 2004),这一方面反映了这一工作的复杂性与艰巨性,同时也说明我们仍然需要继续努力提高失语症患者语言能力康复的有效性。我们对今后相关领域的研究提出如下思考。

5.1 语言康复方案的制订

语言同时具有行为、认知和神经三重属性,可观察到的语言行为背后隐含着语言加工的认知过程,而这些过程又具有复杂的神经基础,因此,脑损伤会导致语言加工认知系统的损坏进而导致外部行为,即语言交际的障碍。总体而言,从不同理论视角提出的康复方案也可以被分为行为、认知和神经三种类型。行为方案通过包括语言和非语言行为的训练带来语言功能的提高和认知能力与神经功能的改善;认知方案通过认知能力的训练来促进语言功能的恢复,而神经方案则通过脑刺激的方式来改善脑的功能,进而提升语言能力。康复训练的实践研究表明,每一种类型的康复方案都有其优势和局限性,而且每种类型之内具体的治疗方法有各自针对的语言障碍类型,虽然它们都可以为患者带来某种程度的语言能力的改善,但其效果都很缓慢、有限(Galletta et al. , 2019)。针对这种状况,一种可行的选择就是采用多种方法结合的方式,目前的许多康复训练(例如,Vines et al. , 2011)采用了行为与神经方案同时进行的方式,也有康复训练采用了认知与行为相结合的方式(例如,杨锐,2019),结果表明,双重治疗的效果要好于单纯的行为、认知或神经治疗的效果。然而目前少见的是把行为、认知和神经三种治疗方式进行结合的康复方案,因此,我们建议下一步的研究可以考虑针对患者的具体情况,分别从三种治疗类型中选择合适的治疗方法,形成行为、认知与神经相互结合的综合性康复方案。

要实现行为、认知和神经三种康复的结合,需要更好地解决学科之间的相互融合问题。目前相关领域研究还存在着明显的学科分野,来自于不同领域的学者分别从各自的理论背景出发制订了不同的康复方案,这些方案往往缺乏其它相关学科的理论基础。在这一方面,由 Pulvermüller et al. (2001)以限制性运动疗法(Constraint-Induced Movement Therapy, CIMT)和失语症交际疗法(Communicative Aphasia Therapy, CAT)为基础提出的限制性失语症疗法(Constraint-Induced Aphasia Therapy, CIAT)为我们提供了很好的借鉴。CIMT 和 CAT 具有不同的理论背景和目标,前者以神经生物学理论为背景,目的在于帮助中风后偏瘫患者恢复肢体的运动功能。它认为偏瘫患者的患侧肢体不能主动活动,常依赖健肢,从而导致患肢形成“习得性失用”。CIMT 以大脑功能重塑为目标,通过限制健侧肢体的运动,同时对患侧进行大量的重复练习以及日常生活相关的活动训练,进而逆转“习得性失用”。CAT 则以语用学和交际理论,尤其是言语行为理论为基础,目的在于帮

中国知网 https://www.cnki.net

助失语症患者恢复语言的交际能力。Pulvermüller et al. (2016)指出,两种疗法都以行为表现为重点,具有行为的关联性,更为重要的是,神经生物学的许多研究表明,人脑中的语言和动作系统并不是相互独立、封闭的,而是相互联结、互为依赖的。因此,CIAT 整合了 CIMT 和 CAT 的思路和方法,严格限制口头表达以外沟通方式的使用,通过大量的言语行为训练迫使大脑重新建立起物品或动作和语言之间的联系。

在康复方案的制订方面,我们还需要重点关注数字技术的应用问题。计算机以及人工智能技术为失语症患者语言功能的康复带来了极大的便利。在国际上,计算机化言语与语言治疗(Computerized Speech and Language Therapy, CSLT)已经成为一个研究热点,并且出现了许多语言康复应用软件,Spaccavento et al. (2021)的研究表明,CSLT 可以起到与由治疗师进行的康复训练相同的效果。

5.2 语言康复方案的实施

康复方案的实施也会直接影响治疗效果,其中一个重要的因素就是康复训练的总量和强度。然而,现在许多的康复方案对于训练的总量和强度都缺乏明确的规定或指导,即使在某些方案对治疗的强度提出了具体建议的情况下,具体的康复实践也有不同的做法。因此,不论是康复方案的制订者还是实施者都需要进一步重视这一问题,并根据每种康复方案的具体情况确定最优的治疗强度和总量。

康复方案的实施还涉及时间问题。失语症可以分为急性发作期(中风发作后 3 个月之内)和慢性期(中风发作后 3 个月之后)两个阶段,确定在哪一个阶段进行语言功能的康复治疗至为重要。现在的大多数研究集中在慢性期,也有少量研究关注急性发作期(例如,Nouwens et al., 2015)。由于样本大小、康复疗程数和治疗类型的差异,对于在两个阶段开展康复治疗效果的研究结论非常不一致(Spaccavento et al., 2021)。一些研究(Kim et al., 2002)表明,脑损伤后不久的神经可塑性最强,而随时间的推移会逐渐变弱。这可能意味着在失语症发病之后要尽早进行语言功能的康复治疗。然而,中风后脑功能与结构重组和可塑性并不一定带来功能的优化,因为具体的恢复过程要取决于损伤的部位和程度;并且有可能产生脑皮质的适应不良(maladaptation),从而导致脑的可塑性变化会阻碍恢复的现象。因此,早期的康复训练也可能会对长期的康复产生负面影响(Fridriksson & Smith, 2016)。目前,我们还需要进一步研究在失语症的不同发展阶段康复治疗效果与神经可塑性之间的关系,谨慎评估人为的康复治疗有可能对自发性恢复所产生的抑制风险。

另外,康复实施者也是今后研究需要重点关注的问题。目前的语言康复主要由专业的治疗师在专门的机构中进行,然而语言功能的恢复是一个漫长的过程,需要家庭与社会的参与。世界卫生组织(2001)制订的国际功能、残疾与健康分类(International Classification of Functioning, Disability and Health, IFC)从损伤、活动和参与三个方面衡量人的健康状况,是目前国际通用的健康分类与评价标准,同时也为失语症患者语言功能的评价与康复提供了重要参考。在 IFC 框架之下,研究者们提出了失语症康复的社会交际

中国知网 https://www.cnki.net

方案,其中一个典型的实例就是失语症生活参与方法(Life Participation Approach to Aphasia, LPAA)。该方法围绕活动与参与两个方面,关注患者需求与思想的交流以及参与生活互动的能力,而不是针对受损的语言技能,它还重视培训护理人员和家庭成员与患者的沟通技能,而不仅仅是患者本人(Galletta et al., 2019)。因此,今后的相关研究还需要更多地关注家庭成员的培训问题,一方面使其更好地与患者进行交流,另一方面也要帮助他们能够把在专门机构进行的一些康复活动延伸至家庭的日常生活之中。

6. 结语

语言是人类区别于其他动物的根本性标志之一,如同空气一样,语言是人类生活不可或缺的组成部分,失语症对于患者生活质量的影响是不言而喻的(刘佳、范琳,2024)。失语症患者语言功能的康复不仅仅是医生的工作,更是语言学研究者不可推卸的责任。从语言学的角度开展失语症患者语言功能的康复研究可以很好地体现语言学的应用价值,我们要发挥自身的语言学理论优势,充分吸收神经生物学和认知神经心理学的相关研究成果,与医学界、心理学界的同仁一起合作,制订出适合我国失语症患者语言、心理和社会文化特点的康复方案,为健康中国的实现贡献力量。

参考文献

[1]Albert, M. L., R. W. Sparks & N. A. Helm. Melodic intonation therapy for aphasia[J]. *Archives of Neurology*, 1973, 29(2): 130-131.

[2]Boyle, M. Semantic feature analysis treatment for aphasic word retrieval impairments: What's in a name?[J]. *Topics in Stroke Rehabilitation*, 2010, 17(6): 411-422.

[3]Chea, M. et al. Listening to classical music influences brain connectivity in post-stroke aphasia: A pilot study[J/OL]. *Annals of Physical and Rehabilitation Medicine*, 2024, 67. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2024.101825.[2024-03-21]

[4]Fillmore, C. The case for case[A]. In E. Bach & R. Harms (eds.). *Universals in Linguistic Theory*[C]. New York: Holt, Reinhart, and Winston, 1968. 1-88.

[5]Fridriksson, J. & K. Smith. Neuroplasticity associated with treated aphasia recovery[A]. In G. Hickok & S. L. Small (eds.). *Neurobiology of Language*[C]. Orlando: Academic Press, 2016. 1007-1013.

[6]Friedmann, N. & Y. Grodzinsky. Tense and agreement in agrammatic production: pruning the syntactic tree[J]. *Brain and Language*, 1997, 56 (3): 397-425.

[7]Friedmann, N., D. Wenkert-Olenik & M. Gil. From theory to practice: Treatment of agrammatic production in Hebrew based on the Tree Pruning Hypothesis[J]. *Journal of Neurolinguistics*, 2000, 13: 250-254.

[8]Galletta, E. E., M. Goral & P. S. Conner. Aphasia rehabilitation[A]. In R. Wilson & P. Raghavan (eds). *Stroke Rehabilitation*[C]. London: Elsevier, 2019. 49-59.

[9]Gilmore, N., E. L. Meier, J. P. Johnson & S. Kiran. Typicality-based semantic treatment for anomia

中国知网 https://www.cnki.net

results in multiple levels of generalization[J]. *Neuropsychological Rehabilitation*, 2020, 30(5): 802-828.

[10] Gleason, J. B., et al. The retrieval of syntax in Broca's aphasia[J]. *Brain and Language*, 1975, 2(4): 451-471.

[11] Hashimoto, N. & A. Frome. The use of a modified semantic features analysis approach in aphasia[J]. *Journal of Communication Disorders*, 2011, 44(4): 459-469.

[12] Helm-Estabrooks, N, P. M. Fitzpatrick & B. Barresi. Response of an agrammatic patient to a syntax stimulation program for aphasia[J]. *Journal of Speech & Hearing Disorders*, 1981, 46(4): 422-427.

[13] Jung, I. Y. et al. The factors associated with good responses to speech therapy combined with transcranial direct current stimulation in post-stroke aphasic patients[J]. *Annals of Rehabilitation Medicine*, 2011, 35(4): 460-469.

[14] Kim, Y. H. et al. Reorganization of cortical language areas in patients with aphasia: A functional MRI study[J]. *Yonsei Medical Journal*, 2002, 43(4): 441-445.

[15] Kiran, S. Complexity in the treatment of naming deficits[J]. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 2007, 16(1): 18-29.

[16] Kristensson, J. & C. Saldert. Naming of objects and actions after treatment with phonological components analysis in aphasia[J]. *Clinical Archives of Communication Disorders*, 2018, 3(2): 137-150.

[17] Lee, J. & G. Man. Language recovery in aphasia following implicit structural priming training: A case study[J]. *Aphasiology*, 2017, 31(12): 1441-1458.

[18] Loverso, F. L., T. E. Prescott & M. Selinger. Cueing verbs: A treatment strategy for aphasic adults[J]. *Journal of Rehabilitation Research*, 1986, 25 (2): 47-60.

[19] Luria, A. R. *Traumatic Aphasia: Its Syndromes, Psychology and Treatment*[M]. The Hague: Mouton, 1970.

[20] Man, G., S. Meehan, N. Martin, H. Branigan & J. Lee. Effects of verb overlap on structural priming in dialogue: Implications for syntactic learning in aphasia[J]. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 2019, 62(6): 1933-1950.

[21] Martin, P. I. et al. Transcranial magnetic stimulation as a complementary treatment for aphasia[J]. *Seminars in Speech and Language*, 2004, 25(2): 181-191.

[22] Naeser, M. A. et al. Improved naming after TMS treatments in a chronic, global aphasia patient—case report[J]. *Neurocase*, 2005, 11(3): 182-193.

[23] Nouwens, F. et al. Optimal timing of speech and language therapy for aphasia after stroke: More evidence needed[J]. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 2015, 15(8): 885-893.

[24] Pedersen, P. M., K. Vinter & T. S. Olsen. Aphasia after stroke: Type, severity and prognosis. The Copenhagen aphasia study[J]. *Cerebrovasular Disease*, 2004, 17: 35-43.

[25] Pulvermüller, F., B. Mohr & E. Taub. Constraint-induced aphasia therapy: A neuroscience-centered translational method[A]. In In G. Hickok & S. L. Small (eds.). *Neurobiology of Language*[C]. Orlando: Academic Press, 2016. 1025-1034.

[26] Pulvermüller, F. et al. Constraint-induced therapy of chronic aphasia after stroke[J]. *Stroke*, 2001, 32(7): 1621-1626.

[27] Rose, M. & J. Douglas. Treating a semantic word production deficit in aphasia with verbal and gesture

中国知网 https://www.cnki.net

methods[J]. *Aphasiology*, 2008, 22(1): 20-41.

[28]Saffran, E., M. F. Schwartz & M. C. Linebarger. Semantic influences on thematic role assignment: Evidence from normals and aphasics[J]. *Brain and Language*, 1998, 62: 255-297.

[29]Schuell, H., V. Carroll & B. S. Street. Clinical treatment of aphasia[J]. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 1955, 20(1): 43-53.

[30]Schwartz, M. F., R. B. Fink & E. M. Saffran. The modular treatment of agrammatism[J]. *Neuropsychological Rehabilitation*, 1995, 5(1-2): 93-127.

[31]Spaccavento, S. et al. Effects of computer-based therapy versus therapist-mediated therapy in stroke-related aphasia: Pilot non-inferiority study[J/OL]. *Journal of Communication Disorders*, 2021, 94. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106158.[2024-05-07]

[32]Szaflarski, J. P. et al. A feasibility study of combined intermittent theta burst stimulation and modified constraint-induced aphasia therapy in chronic post-stroke aphasia[J]. *Restorative Neurology and Neuroscience*, 2018, 36(4): 503-518.

[33]Thompson, C. K. Unaccusative verb production in agrammatic aphasia: The argument structure complexity hypothesis[J]. *Journal of Neurolinguistics*, 2003, 16: 151-167.

[34]Thompson, C. K. & L. P. Shapiro. Treating agrammatic aphasia within a linguistic framework: Treatment of underlying forms[J]. *Aphasiology*, 2005, 19(10-11): 1021-1036.

[35]Thompson, C. K. & L. P. Shapiro. Complexity in treatment of syntactic deficits[J]. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 2007, 16(1): 30-42.

[36]Vines, B. W., A. C. Norton & G. Schlaug. Non-invasive brain stimulation enhances the effects of melodic intonation therapy[J]. *Frontiers in Psychology*, 2011, 2. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00230 30.[2024-05-10]

[37]Wambaugh, J. L., S. Mauszycki & S. Wright. Semantic feature analysis: Application to confrontation naming of actions in aphasia[J]. *Aphasiology*, 2014, 28(1): 1-24.

[38]Webster, J. & B. Gordon. Contrasting therapy effects for verb and sentence processing difficulties: A discussion of what worked and why[J]. *Aphasiology*, 2009, 23(10): 1231-1251.

[39]Whitworth, A., J. Webster & D. Howard. *A Cognitive Neuropsychological Approach to Assessment and Intervention in Aphasia: A Clinician's Guide*(2nd ed.)[M]. Hove: Psychology Press, 2014.

[40]World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health*[M]. Geneva: ICF, 2001.

[41]常辉,王海燕. 失语症研究的语言学转向[J]. 山东外语教学,2024,(3): 34-44.

[42]刘佳,范琳. 汉语失语症研究:回顾与展望[J]. 山东外语教学,2024,(3): 23-33.

[43]杨悦. 语言训练联合认知功能康复训练治疗脑卒中失语症的效果评价[J]. 按摩与康复医学,2019,(16): 11-13.

[44]张梦瑶. 歌唱疗法对脑卒中失语症康复作用的研究[D]. 中国音乐学院硕士论文,2023.

[45]朱仁敬等. 认知功能训练对脑卒中后失语症康复效果的影响[J]. 深圳中西医结合杂志, 2020,(23): 28-29.

(责任编辑:孙炬)

中国知网　https://www.cnki.net